Клинические рекомендации

Коронавирусная инфекция COVID-19

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**U07.1** — COVID-19, вирус идентифицирован **U07.2** — COVID-19, вирус не идентифицирован
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.01.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1024_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Классификация 2

2.3 Клиническая картина 3

3. Диагностика 3

3.1 Жалобы и анамнез 3

3.2 Лабораторные исследования 3

3.3 Инструментальные исследования 3

4. Лечение 4

4.1 Лёгкое и среднетяжёлое течение (амбулаторно) 4

4.2 Среднетяжёлое и тяжёлое течение 4

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 4

5.1 Профилактика 4

5.2 Организация помощи и госпитализация 5

6. Источник и актуальность 5

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 5

1. Основные положения

- Коронавирусная инфекция COVID-19 — инфекция, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Отдельная клиническая форма — поражение органов обоняния: аносмия, паросмия, какосмия.
- Для этиологической диагностики выполняется молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на SARS-CoV-2; всем пациентам — пульсоксиметрия на всех этапах помощи.
- При лёгком и среднетяжёлом течении — противовирусные препараты прямого действия **в первые 7 дней болезни**, жаропонижающие при температуре **выше 38 °C**, при выраженном затруднении носового дыхания — сосудосуживающие капли **не более 5 дней**.
- Госпитализации подлежат пациенты с тяжёлым и среднетяжёлым течением, из групп риска и по эпидемиологическим показаниям. Выписка — при SpO_2 **95%** на воздухе, температуре **ниже 37,5 °C**, СРБ **ниже 10 мг/л**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Коронавирусная инфекция COVID-19 — инфекция, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.

2.2 Классификация

Клинические варианты и проявления

1. **респираторная форма** — острая респираторная инфекция дыхательных путей (поражение только верхних отделов), пневмония без ОДН и с ОДН
2. **гастроинтестинальная форма** — энтерит, гепатит
3. **церебральная форма** — менингит, менингоэнцефалит
4. **поражение органов обоняния и осязания** — аносмия, паросмия, какосмия
5. **особые формы** — сочетанная, малосимптомная или бессимптомная, нейтропеническая
6. **осложнения** — сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок, ДВС-синдром, тромбозы и тромбоэмболии

Степени тяжести COVID-19

Степень тяжести	Критерии
лёгкое течение	1. температура **ниже 38 °C**, кашель, слабость, боли в горле 2. нет критериев среднетяжёлого и тяжёлого течения
среднетяжёлое течение	1. температура **выше 38 °C** 2. ЧДД **более 22 в минуту**, одышка при нагрузке 3. изменения на КТ (рентгенографии), типичные для вирусного поражения 4. SpO_2 **ниже 95%** 5. СРБ **более 10 мг/л**
тяжёлое течение	1. ЧДД **более 30 в минуту** 2. SpO_2 **93% и ниже**, PaO_2/FiO_2 300 мм рт. ст. и ниже 3. снижение уровня сознания, ажитация 4. нестабильная гемодинамика 5. лактат артериальной крови **более 2 ммоль/л**, qSOFA более 2 баллов

Степень тяжести	Критерии
крайне тяжёлое течение	1. стойкая фебрильная лихорадка 2. ОРДС, ОДН с необходимостью инвазивной вентиляции 3. септический шок, полиорганная недостаточность

2.3 Клиническая картина

Инкубационный период при варианте Омикрон короче — 2–7 суток, в среднем 3–4 суток (до его распространения — 2–14 суток, в среднем 5–7).

Характерны клинические симптомы ОРВИ: повышение температуры тела, сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке.

Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

В постковидном периоде нарушения обоняния и вкуса могут сохраняться неопределённый срок, иногда до 1 года; в некоторых случаях полного восстановления не происходит.

---

3. Диагностика

3.1 Жалобы и анамнез

Обращают внимание на наличие и сроки появления

1. лихорадки и интоксикации: головная боль, слабость, утомляемость, мышечные боли, снижение аппетита;
2. ощущения «заложенности» в грудной клетке, одышки;
3. катаральных явлений: насморк, боли или першение в ротоглотке, сухой кашель, скудная мокрота, конъюнктивит;
4. нарушения или потери обоняния (гипосмия, аносмия), потери вкуса (дисгевзия);
5. рвоты, диареи, кожных высыпаний.

3.2 Лабораторные исследования

Для этиологической диагностики у пациентов с подозрением на COVID-19 выполняется молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на коронавирус SARS-CoV-2.

Выявление антигенов SARS-CoV-2 иммунохроматографическими методами также применяется для этиологической диагностики.

3.3 Инструментальные исследования

Всем пациентам с подозрением на COVID-19 на всех этапах помощи выполняется пульсоксиметрия с измерением SpO_2 для выявления дыхательной недостаточности.

КТ органов грудной полости выполняется при среднетяжёлом, тяжёлом и крайне тяжёлом течении.

1. **кардиолог** — симптомы миокардита, острой сердечно-сосудистой недостаточности
2. **акушер-гинеколог** — COVID-19 при беременности
3. **психиатр** — психоз и делирий у пожилых
4. **эндокринолог** — сахарный диабет

4. Лечение

Основной подход к терапии — упреждающее назначение лечения, чтобы предотвратить пневмонию, ОРДС и сепсис; лечение проводится в подтверждённых и вероятных случаях.

4.1 Лёгкое и среднетяжёлое течение (амбулаторно)

Противовирусные препараты прямого действия назначаются всем пациентам с лёгким и среднетяжёлым течением, в том числе с высоким риском прогрессирования, **в течение первых 7 дней болезни** или при положительном тесте на РНК или антигены SARS-CoV-2.

1. молнупиравир: 800 мг внутрь 2 раза в сутки 5 суток
2. фавипиравир, масса менее 75 кг: 1600 мг 2 раза в 1-й день, далее 600 мг 2 раза в сутки со 2 по 10 день
3. фавипиравир, масса 75 кг и более: 1800 мг 2 раза в 1-й день, далее 800 мг 2 раза в сутки со 2 по 10 день

При гипертермии **выше 38 °C**, мышечных и суставных болях:

1. ибупрофен: 200–400 мг 3–4 раза в сутки 3–10 дней, максимум 1200 мг в сутки
1. парацетамол: 500–1000 мг до 4 раз в сутки, максимум 4000 мг в сутки

При сухом непродуктивном кашле — бутамират или леводропропизин; муколитики — ацетилцистеин, бромгексин, амброксол.

1. ацетилцистеин: 200 мг внутрь 2–3 раза в сутки 5 дней
2. амброксол: 30 мг 3 раза в сутки внутрь 5 дней

Одновременное применение отхаркивающих и противокашлевых средств не рекомендуется: подавление кашлевого рефлекса способствует застою мокроты.

При выраженном затруднении носового дыхания в комплексной терапии ринита и риносинусита применяются сосудосуживающие средства — для облегчения заложенности носа и восстановления проходимости слуховой трубы, **не более 5 дней**.

1. нафазолин 0,1%: по 1–3 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки
2. ксилометазолин 0,1%: по 2–3 капли или одно впрыскивание в каждую ноздрю 4 раза в день
3. оксиметазолин 0,025–0,05%: по 1–2 капли 2–3 раза в сутки или по 2–3 впрыскивания 0,05% спрея

4.2 Среднетяжёлое и тяжёлое течение

При среднетяжёлом течении с изменениями в лёгких и/или факторами риска прогрессии в сочетании с двумя и более признаками (SpO_2 94–96%, одышка при нагрузке, повышение СРБ, температура 38 °C 3–5 дней, лейкопения, лимфопения) назначают глюкокортикоиды и ингибиторы интерлейкинов в комбинации с противовирусными препаратами.

Респираторная поддержка — от низкопоточной оксигенотерапии через лицевую маску при лёгкой или средней гипоксемии до интубации трахеи и ИВЛ при острой дыхательной недостаточности.

Интубация трахеи и ИВЛ проводятся при острой дыхательной недостаточности для обеспечения газообмена.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Рекомендована вакцинация всем лицам без противопоказаний вакциной, зарегистрированной в РФ, в предэпидемический период.

Всем лицам для предотвращения заражения рекомендовано орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором натрия хлорида.

Лицам, имевшим контакт с больными COVID-19 и ОРВИ, проводится химиопрофилактика.

5.2 Организация помощи и госпитализация

На дому помощь оказывается при отсутствии клинических проявлений или лёгком течении, при соблюдении условий — и при среднетяжёлом.

Пациента информируют о вызове врача при ухудшении

1. температура **выше 38,5 °C в течение 3 дней и более**;
2. затруднённое дыхание, одышка;
3. SpO_2 **ниже 93%**.

Госпитализации подлежат больные

1. с тяжёлым и среднетяжёлым течением;
2. относящиеся к группе риска;
3. по эпидемиологическим показаниям.

Перевод на койки долечивания

1. стойкое улучшение клинической картины;
2. SpO_2 на воздухе **93%**;
3. температура **ниже 37,5 °C**;
4. СРБ **ниже 30 мг/л**;
5. лимфоциты крови более 1×10^9/л.

Критерии выписки на амбулаторное лечение

1. стойкое улучшение клинической картины;
2. SpO_2 на воздухе **95%**;
3. температура **ниже 37,5 °C**;
4. СРБ **ниже 10 мг/л**;
5. лимфоциты крови более $1{,}2\times10^9$/л.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Коронавирусная инфекция COVID-19»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 28.01.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2029 года
Код в рубрикаторе	`1024_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.